RUTA CLÍNICA: SÍNDROME CORONARIO AGUDO

1. INGRESO DEL PACIENTE

DOLOR TORACICO

CORONARIO
-Dolor opresivo o tipo quemazón retroesternal
-Irradia a brazo izquierdo, cuello o mandíbula
-Empeora con actividad física y dura >10 min

Anamnesis Dirigida
Registro en Historia Clínica

Equivalentes Anginosos

Síndrome Coronario

TOMAR EKG EN LOS PRIMEROS 10 MINUTOS

VII y VIII
Femenina >1.5 mm
Masculino <40 años >2.5 mm
Masculino >40 años >2.0 mm

>1 mm en derivaciones excepto VII y VIII

ELEVACIÓN ST

Equivalentes en EKG
Ondas T altas hiperagudas
Bloqueos de rama de novo
Infradesnivel del ST
Patrón de Winter, Wellens

Monitoreo Continuo

Sat de O2 < 90% -> Oxígeno suplementario
Dolor -> Manejo con Nitratos y/o Morfina

Terapia Antitrombótica

ASA 300mg Inicial -> Continuar a 100 mg/día
Clopidogrel 600 mg Inicial -> Continuar 75 mg/día
Enoxaparina 1mg/Kg/día
Atorvastatina 40-80 mg

Si se va a realizar Trombolisis , Clopidogrel: 300 mg de carga y en >75 años no se da carga

Enoxaparina 0,75 mg/Kg
En TFG <30 mL/min/1.73m2 o >75 años

¿ICP <120 min ?

Si

Derivar a Hemodinamia

No

Fibrinolisis <30 min

Alteplase:
15 mg bolo IV, seguido de 0,75 mg/kg (máx. 50 mg) en 30 min, luego 0,5 mg/kg (máx. 35 mg) en 60 min: max. total: 100 mg o 1,5 mg/kg si <65 kg

Tenecteplase Máx. 50 mg:
<60 kg: 30 mg
60-69 kg: 35 mg
70-79 kg: 40 mg
80-89 kg: 45 mg
≥90 kg: 50 mg.

Posteriormente

Monitorizar en UCI
Evaluar éxito 60-90 min
Control EKG
Posibilidad de ICP

NO ELEVACIÓN ST

Troponina I

Percentil >99

Negativo

-Falla Cardiaca
-Pancreatitis
-IAM
-Sepsis
-TEP

Si persiste sospecha

Indeterminado

Delta de Troponina

0 - 3 - 6 -

Estudiar otras causas

Positivo

Causas no Coronarias de Troponinas elevadas

1. I. congestiva cardiaca grave: aguda y crónica
2. Disección aorta, valvulopatía aórtica, miocardiopatía hipertrófica
3. Contusión cardiaca, ablación, cardioversión
4. Enfermedades inflamatorias (miocarditis, pericarditis)
5. Crisis hipertensiva
6. Taqui o bradiarritmias
7. Embolia pulmonar, HTP severa
8. Hipotiroidismo
9. Disfunción renal crónica o aguda
10. Enfermedad neurológica aguda (ACV, HSA)
11. Enfermedades infiltrativas (amiloidosis, sarcoidosis)
12. Toxicidad fármacos (venenos, adriamicina)
13. Quemaduras más 30% superficie corporal
14. Rabdomiolisis
15. Pacientes críticos (insuficiencia respiratoria, sepsis)

Escalas de Riesgo
(GRACE)

Bajo Riesgo <109

Estrategia no Invasiva

Prueba de Esfuerzo
CCTA
Síntomas Recurrentes

Riesgo Intermedio
109-140

Arteriografía Coronaria
<72h

Riesgo Alto >140

Arteriografía Coronaria
<24h

Riesgo Muy Alto

Estrategia Invasiva

Revascularización

Estratificación de riesgo en hospitalización
Seguimiento de síntomas

Arteriografía Coronaria
Antes del Egreso

Cardiaco

-Pericarditis, Miocarditis
-Disección aórtica, Aneurisma aórtico
-Problemas valvulares
-Taponamiento Cardiaco

Abordaje específico por Patología

No Cardiaco

-Costocondritis
-Reflujo Gastroesofágico, Úlcera péptica, Gastritis
-Espasmo esofágico
-Pleuritis, neumonía, TEP
-Ansiedad/Pánico
-Herpes

Abordaje específico por Patología

Bibliografía:

Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, Barbato E, Berry C, Chieffo A, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care [Internet]. 2024;13(1):55–161. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1093/ehjacc/zuad107